

Contention physique en ESMS

Et mesures restrictives de la liberté d'aller et venir : prescrire, surveiller, tracer.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME · IEM

FICHE PRATIQUE
DOTR

Mise à jour : septembre 2026

À RETENIR

La contention physique est une mesure de dernier recours : prescription médicale motivée, durée limitée — 24 h renouvelable après réévaluation —, surveillance programmée, proches informés. Elle ne prévient pas les chutes.

Sources : ANAES 2000 · Consensus 2004 · HAS 2005

JAMAIS

Pour pallier un **manque d'effectif**, par **convenance** de l'équipe, par mesure **disciplinaire** ou **punitive** · de façon **systématique** · avec du **matériel détourné** (draps, vêtements, liens de fortune).

Sources : ANAES 2000 · Consensus 2004

1. Identifier la nature de la mesure

PRÉVENTION — NON RESTRICTIVE

Alternatives à la contention

Traiter une cause (douleur, hypotension, glycémie) · revoir les traitements · lit bas sans barrières · éclairage · déambulation sécurisée · activités · présence des proches · toilettes accompagnées.

Maintien postural

Corset-siège, siège moulé, sangle de positionnement : attitude corrigée, **ne se confond pas** avec la contention passive.

Retrait préventif, porte ouverte

Volontaire ou négocié, sans restriction.

Sources : ANAES 2000 · Afssaps 2006 · ANSM 2020 · HAS 2020 polyhandicap · ANESM 2016-2017

CONTENTION PHYSIQUE PASSIVE

Tout moyen, matériel ou vêtement qui **empêche ou limite la mobilisation volontaire** de tout ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir la sécurité.

Au lit

Barrières relevées · ceinture ou sangle · couchage de contention.

Au fauteuil

Ceinture ou sangle · tablette fixée · siège géométrique ou basculé · gilet, harnais.

Membres et vêtements

Attaches de poignets ou de chevilles · combinaison, moufles.

Sources : ANAES 2000 · ANSM 2020

LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR

Restreint les déplacements sans immobiliser le corps.

- Chambre fermée à clé, **confinement**
- Espace de calme-retrait **fermé**
- Accès contrôlé, digicode, localisation : un **pis-aller** — intervention humaine préférable

Exceptionnelle, **collégiale**, motivée, portée au dossier et au registre, **information rapide de l'entourage**.
EHPAD : annexe au contrat de séjour.

Sources : Consensus 2004 · ANESM 2016-2017 · CASF L311-4-1

2. Le motif justifie-t-il une contention ?

MOTIF INVOQUÉ	STATUT ET CE QUE DISENT LES SOURCES
Risque de chute	Efficacité non démontrée Aucune preuve d'efficacité ; la contention est un facteur indépendant de gravité de la chute. Ne justifie pas, à lui seul, une contention.
Déambulation, errance	Efficacité non démontrée Sans preuve d'efficacité, pas une véritable indication médicale. Alternative : espace de déambulation sécurisé.
Agitation	Efficacité non démontrée Sans preuve d'efficacité ; la contention peut aggraver confusion et agitation. Rechercher et traiter une cause.
Mise en danger de soi	Dernier recours possible Envisageable en dernier recours, après appréciation du danger et échec des alternatives.
Danger pour autrui	Dernier recours possible Envisageable en dernier recours, après appréciation du danger pour la personne et les tiers.
Protection d'un dispositif médical	Règles générales Non détaillé par les sources consultées : règles générales — dernier recours, durée la plus courte, réévaluation.
Sortie dangereuse, risque de fugue	Liberté d'aller et venir Liberté d'aller et venir : intervention humaine et aménagement préférables aux dispositifs électroniques ; EHPAD : annexe au contrat de séjour.
Glissement au fauteuil	Positionnement Relève du maintien postural, pas de la contention passive.

Sources : ANAES 2000 · HAS 2005 · Consensus 2004 · HAS 2009 · ANESM 2016-2017 · CASF L311-4-1 · ANSM 2020

Note : fiche de repères pour les médecins DOTR ; elle ne remplace ni le protocole de l'établissement ni l'évaluation clinique.
Recommandations citées : 2000 à 2020 — aucune recommandation HAS plus récente propre à la contention en ESMS n'a été trouvée.

VMS
Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

3. Prescrire

CONTENU DE LA PRESCRIPTION

Avant de prescrire

- **Danger** apprécié pour la personne et pour les tiers
- **Alternatives** tentées et tracées
- Rapport **bénéfice/risque** apprécié par l'équipe pluridisciplinaire
- Personne et proches **informés** des raisons et des buts ; consentement et participation recherchés

La prescription précise

- Écrite, horodatée, prescripteur identifié
- Motifs de la contention
- Durée prévisible / période de mise en place
- Risques à prévenir
- Programme de surveillance
- Matériel de contention

Urgence : en l'absence de médecin, prescription possible a posteriori, confirmée dans les plus brefs délais par un médecin.

Sources : ANAES 2000 - Consensus 2004 - ANSM 2020

DURÉES ET SURVEILLANCE — REPÈRES

Validité de la prescription

24 h, reconduite si nécessaire après réévaluation, par une prescription motivée. Couchage de contention : **12 h** à la première utilisation, puis 24 h.

Contrôle — au moins toutes les heures

Fonction respiratoire · peau aux points d'attache et d'appui · hydratation · continence.

Levée de la contention

Aussi souvent que possible — **au moins toutes les 2 h** selon certains auteurs — pour maintenir l'état fonctionnel.

Réévaluation médicale

État de santé et conséquences de la contention : **au moins toutes les 24 h**, tracée.

Soins programmés

Hygiène, nutrition, hydratation, accompagnement psychologique, activités ; intimité et dignité préservées.

Plus strict : le consensus 2004 réserve la contention à l'urgence médicale, avec réévaluation **toutes les 3 h au plus**.

Sources : ANAES 2000 - ANSM 2020 - Consensus 2004

4. Qui décide, qui informe

EHPAD

Contention : prescription médicale motivée.

Liberté d'aller et venir : annexe au contrat de séjour.

- Examen du résident, procédure **collégiale** à l'initiative du médecin coordonnateur (à défaut, du médecin traitant)
- Évaluation pluridisciplinaire bénéfices/risques, conservée au dossier médical
- Consentement recherché mesure par mesure
- Réévaluation au moins tous les **six mois**

Sources : ANAES 2000 - CASF L311-4-1

MAS · FAM · EAM

Aucun texte spécifique trouvé : l'annexe au contrat de séjour ne vise que les établissements pour personnes âgées.

S'appliquent les recommandations :

- Mesure d'exception, **dernier recours** face à un danger immédiat, levée dès que les motifs disparaissent
- Prescription médicale en temps réel
- Protocole individualisé, gestes de protection appris en formation
- **Débriefing** après toute mesure restrictive, **rapport d'incident**, instance éthique si elle existe
- Adhésion de la personne et de ses représentants recherchée

Sources : CASF L311-4-1 · ANESM 2016-2017 · Consensus 2004

IME · IEM (MINEURS)

- Titulaires de l'autorité parentale **informés**, consentement et participation recherchés
- Consentement du mineur **systématiquement recherché** s'il est apte à exprimer sa volonté
- Enfant associé aux décisions selon son âge et sa maturité
- Espaces de calme-retrait : adhésion des parents **formalisée**

Sources : ANAES 2000 · CSP L1111-4 · C. civ. 371-1 · ANESM 2016-2017

MAJEUR PROTÉGÉ

- **Mesure avec assistance** : consentement de la personne recherché, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection.
- **Représentation relative à la personne** : consentement obtenu si la personne est apte ; à défaut, autorisation de la personne chargée de la protection, qui tient compte de l'avis exprimé. Désaccord hors urgence : le juge tranche.

Sources : CSP L1111-4 · C. civ. 459

URGENCE

- Prescription possible **a posteriori**, confirmée dans les plus brefs délais par un médecin.
- **EHPAD, mesures relevant de l'annexe** : le médecin coordonnateur et le directeur prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir **à lui-même** ; ils informent **immédiatement** le protecteur ou la personne de confiance ; sans mesure de protection, **sauvegarde de justice** déclarée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur ; mesures inscrites ensuite dans l'annexe.
- Information des proches **dès que possible**, tracée.

Sources : ANAES 2000 · CASF R311-0-8 · Consensus 2004

Note : fiche de repères pour les médecins DOTR ; elle ne remplace ni le protocole de l'établissement ni l'évaluation clinique. Recommandations citées : 2000 à 2020 — aucune recommandation HAS plus récente propre à la contention en ESMS n'a été trouvée.

5. Sécuriser le matériel

AU LIT

Barrières de lit

- Barrières non conçues pour empêcher une sortie volontaire du lit : risque de chute par-dessus et de piégeage (tête, cou, thorax, membres).
- Barrière compatible avec le lit et le matelas ; verrouillage vérifié à chaque utilisation ; revoir les dimensions en cas de sur-matelas ou de matelas thérapeutique.
- Lit en position basse en dehors des soins.
- Protège-barrières possibles pour éviter le piégeage des membres.

Ceinture au lit

- Fixation aux parties fixes, sommier ou cadre du lit, jamais au matelas ni aux barrières ; lit réglable : fixer aux parties qui bougent avec le patient.
- Maintien pelvien recommandé ; dispositif de taille adaptée à la morphologie.
- Barrières latérales entières, en position haute, compatibles avec le lit, verrouillées.
- Éviter l'attache à la tête du lit (compression axillaire) ; prévenir régurgitations et escarres en position allongée.

Couchage de contention

- Retirer immédiatement le dispositif si le patient s'agite dedans.
- Vérifier l'absence de compression ou de piégeage lors du gonflement d'un matelas à air.

Sources : Afssaps 2006 · ANSM 2020 · ANAES 2000

AU FAUTEUIL ET AUX MEMBRES

Ceinture au fauteuil

- Maintien pelvien conseillé ; sangles placées au bon endroit, serrage adapté, aucun nœud.
- Palettes repose-pieds réglées (hauteur, inclinaison, profondeur) pour éviter le glissement ; fauteuil adapté à la morphologie, résident assis au fond du siège.
- Dispositif prévu pour le fauteuil et de taille adaptée. Décès rapportés lors de tentatives d'extraction du fauteuil.

Gilet / harnais

- Risque de strangulation ou de compression thoracique en cas de glissement : maintien pelvien recommandé.
- Dispositif de taille adaptée, installé selon les consignes du fabricant, par un personnel formé.

Attaches des membres

- Matériel conforme, en bon état, adapté à la taille ; jamais de lien de fortune.
- Contrôle de l'état cutané aux points d'attache à chaque passage.

Sources : ANSM 2020 · ANAES 2000

SÉCURITÉ

La HAS rappelle aux EHPAD en 2026 : **limiter le recours à la contention physique passive** et, si elle ne peut être évitée, respecter les bonnes pratiques d'utilisation. Entre 2011 et 2019, **130 signalements** liés aux dispositifs médicaux de contention ont été déclarés à l'ANSM, dont des **décès** au fauteuil, au lit et en couchage de contention — souvent lors de tentatives d'extraction du dispositif. Un dispositif de contention n'est manipulé que par un **personnel formé**.

Sources : HAS 2026 · ANSM 2020

6. Tracer

DANS LE DOSSIER DU RÉSIDENT

- Prescription motivée dans le dossier du résident
- Surveillance programmée, mise en œuvre et retranscrite
- Registre des contentions et confinements consultable dans l'établissement
- Réévaluation tracée à chaque renouvellement
- Handicap : alternatives réalisées, information de la personne, surveillance et vérifications tracées ; débriefing après toute mesure restrictive ; rapport d'incident

Sources : ANAES 2000 · Consensus 2004 · ANESM 2016-2017

NE PAS TRANSPOSER LA PSYCHIATRIE

Les durées légales de l'isolement et de la contention en psychiatrie — **contention de 6 h renouvelable, 24 h au total** — visent les patients hospitalisés **sans consentement** en établissement autorisé en psychiatrie.

Elles **ne s'appliquent pas** aux ESMS.

Sources : CSP L3222-5-1

7. Prescrire en quelques clics : l'outil de l'Espace VMS

OUTIL « PRESCRIPTION DE CONTENTION » — RUBRIQUE CONTENTIONS

Choisir la mesure et le ou les motifs dans les menus déroulants : l'outil affiche la nature de la mesure, les alertes des sources et les consignes de sécurité du matériel. Les durées et fréquences sont préremplies avec les repères ci-dessus et **restent modifiables** ; l'échéance de la prescription est calculée.

- **PDF d'une page**, individualisé, à imprimer et signer
- **Texte structuré** (gras, souligné) à copier-coller dans le logiciel de l'établissement : Copier dans l'outil, puis coller dans l'observation médicale ou le module de prescription du dossier du résident (Cmd + V sur Mac, Ctrl + V sur PC)
- Aucune donnée n'est envoyée sur Internet : tout reste sur le poste

Sources et textes de référence

ANAES 2000 — ANAES (HAS), « Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée », octobre 2000 — référentiel en 10 critères (p. 19-20) ; outil HAS mis à jour le 25/01/2010. <https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/contention.pdf>

Consensus 2004 — ANAES / FHF, conférence de consensus « Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité », 24-25 novembre 2004 (texte long, p. 20-24). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/Liberte_aller_venir_long.pdf

HAS 2005 — HAS / SFDRMG, « Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée », novembre 2005 (recommandations et argumentaire, p. 16). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/prevention_des_chutes_-_argumentaire.pdf.pdf

HAS 2009 — HAS, « Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs », mai 2009 (p. 12). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-07/maladie_dalzheimer-troubles_du_comportement_perturbateurs-recommandations.pdf

ANSM 2020 — ANSM, rapport « Sécurisation d'un patient à l'aide d'un dispositif médical de contention mécanique ou de maintien postural », octobre 2020, et fiches de recommandations lit, fauteuil et couchage (mises à jour le 10/11/2021). <https://ansm.sante.fr/actualites/recommandations-pour-assurer-la-securite-des-patients-necessitant-une-contention-medecale>

Afssaps 2006 — Afssaps, « Bonne utilisation des barrières de lit » et « Pour une utilisation sécurisée des barrières de lit — Questions/Réponses », janvier 2006. https://archive.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/3cbe284a28a22fcb800dad4f6728bc0.pdf

ANESM 2016-2017 — ANESM (HAS), « Les comportements-problèmes au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés : prévention et réponses », volets 1 et 2 (2016, p. 94 et 107-108 : « Les mesures d'exception »), synthèse-outils (p. 8 et 36-39) et volet 3 « Les espaces de calme-retrait et d'apaisement » (2017). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/web_anesm_synthese-outils_rbpp-2.pdf

HAS 2020 polyhandicap — HAS, recommandation « L'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité — Les dimensions fonctionnelles », 2020 (p. 25-26). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_2_dimensions_fonct.pdf

HAS 2026 — HAS, « Analyse des déclarations d'EIGS en lien avec les Ehpad », outil d'amélioration des pratiques mis en ligne le 16/09/2026. https://www.has-sante.fr/jcms/p_4126767/fr/analyse-des-declarations-d-eigs-en-lien-avec-les-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad

CASF L311-4-1 — Code de l'action sociale et des familles, art. L311-4-1 (version en vigueur depuis le 10/04/2024), art. R311-0-5 à R311-0-9 (décret n° 2016-1743 du 15/12/2016) et annexe 3-9-1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721307

CASF R311-0-8 — Code de l'action sociale et des familles, art. R311-0-8 (mesures provisoires en cas de force majeure), version en vigueur depuis le 01/09/2018 (décret n° 2018-767 du 31/08/2018). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037362263

CSP L1111-4 — Code de la santé publique, art. L1111-4 (consentement ; mineur ; majeur protégé). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056

C. civ. 459 — Code civil, art. 459 (décisions relatives à la personne du majeur protégé), version en vigueur depuis le 25/03/2019. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310445

C. civ. 371-1 — Code civil, art. 371-1 (autorité parentale), version en vigueur depuis le 21/02/2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164413

CSP L3222-5-1 — Code de la santé publique, art. L3222-5-1 et instruction DGOS/R4/2022/85 du 29/03/2022 : isolement et contention en psychiatrie, patients en hospitalisation complète sans consentement — dispositif propre aux établissements autorisés en psychiatrie. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048447133

Note : fiche de repères pour les médecins DOTR ; elle ne remplace ni le protocole de l'établissement ni l'évaluation clinique.
Recommandations citées : 2000 à 2020 — aucune recommandation HAS plus récente propre à la contention en ESMS n'a été trouvée.

VMS
Vision Moderne de la Santé

 **Docs** On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.